Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Austin Mattheo Martinez Ahumada			Sexo	F	M	✓
Fecha Nacimiento	04-05-2017	Edad actual	8 años	10 meses	País natal:	Chilena	
Domicilio actual:	Los Senderos, Laura Rodríguez 946			Teléfono	962857753		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Escolaridad actual:	2°	Establecimiento					

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 13-03-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Sonia Ahumada	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 13-03-26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Macarena Meneses M.	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Muchas anotaciones en el otro colegio por su inquieto.
Muy distraído incluso en su casa, se frustra al ver muchas tareas.
Dificultad en asignaturas fuertes.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☐ Sí (especificar)	
Pediatría:	Psicología: dice que tiene déficit atencional
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional: Sensorial, [illegible] lectora
Neurología:	Otro:

TDA - comorbilidad ansiosa.

Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 3,480 | Talla: 48,5

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

madre con hipotiroidismo y Colestasis.
parto inducido. a las 39 semanas

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	[✓ No]	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	Sí	[✓ No]	Enfermedad respiratoria	[✓ Sí]	No	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	[✓ Sí]	No			
Hospitalizaciones	Sí	[✓ No]	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	Sí	No	Vacunas	Si	No

Observaciones: 2 meses con rinofaringitis
asma al año y actualmente controlado

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 8 meses	Se sienta sólo/a: 8 meses	Camina sin apoyo: 2 años
Primeras palabras: 8 meses	Primeras frases: al año	Se viste solo/a: 6 años

Controla esfínter vesical Diurno: / Nocturno: / al año	Controla esfínter anal Diurno: / Nocturno:________

Observaciones:

Sin observaciones

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☐ activo ☑ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	Sí	[✓ No]	Dominancia lateral zurdo	[✓ Sí]	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	[✓ Sí]	No
Ensarta	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe	[✓ Sí]	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones / se opone a veces	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	[✓ No]

Observaciones:

Sin observaciones

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	[✓ No]	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	[✓ No]
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos cuando pequeño	Sí	[✓ No]
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	[✓ No]	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	[✓ No]	La pronunciación oral es adecuada	[✓ Sí]	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones: de pequeño incomodaba los sonidos

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	[✓ Sí]	No	Relata experiencias	[✓ Sí]	No
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	[✓ Sí]	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	[✓ No]
Comprende conceptos abstractos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones grupales	[✓ Sí]	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	[✓ Sí]	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

Observaciones: Sin observaciones

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	[✓ Sí]	No	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	[✓ Sí]	No	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales	[✓ Sí]	No	Respeta normas escolares a veces	Sí	No
Opta por trabajo individual	[✓ Sí]	No	Muestra sentido del humor	[✓ Sí]	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	[✓ No]	Movimientos estereotipados	[✓ Sí]	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	[✓ Sí]	No	Pataletas frecuentes a veces	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es: Se muerde mucho los labios

Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☐ natural ☐ desmesurada	**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	[✓ Sí]	No	Trastorno motor	Sí	[✓ No]
Epilepsia	Sí	[✓ No]	Problema bronco-respiratorio 2 años	[✓ Sí]	No
Problemas cardiacos	Sí	[✓ No]	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	[✓ No]
Paraplejia	Sí	[✓ No]	Trastorno emocional	[✓ Sí]	No
Pérdida auditiva	Sí	[✓ No]	Trastorno conductual	Sí	[✓ No]
Pérdida visual	Sí	[✓ No]	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Esta con Psicologo, que fue a sensible trastorno desafiante

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☒ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique) Selección de alimentos

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☒ inquieto Horas que duerme: 8 hrs

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☒ acompañado
(Especifique): Con mamá

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☒ alegre ☒ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☒ triste ☒ serio ☒ rebelde ☒ apático ☒ violento(a) aveces por el telefono
Otro:

Observaciones:

trabajar con TO. Comidas, come papas fritas nada de verdes, arroz, y papillas. toma melatonina antes dormir a poco

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Dionio Ahumada	mamá	24	cursando téc. superior	Garzona
2. Bayron Ayala	amigo mamá	28	cursando tecnico	recepcionista
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

abuelos de niño con diabetes

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4	Asistió a jardín infantil	[✓ Sí]	No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza [✓ Regular] Especial ☐ Técnica ☐:		

Motivo de los cambios: Cambio de casa y no tenía apoyo de colegio anterior

Ha repetido curso/s	Sí	[✓ No]	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	3°		**Dificultad de aprendizaje**	[✓ Sí]	No	**Dificultad para participar**	Sí	[✓ No]	**Conducta disruptiva**	[✓ Sí]	No
Asiste regularmente	[✓ Sí]	No	Asiste con agrado no mucho	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	[✓ Sí]	No	Amigos (as)	Sí	[✓ No]

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☑ castigo ☐ indiferencia ☑ compasión ☐ tensión ☐ otra ...castigo es quitar teléfono

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☑ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s)....................

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Psicopedagogo en Posmi de Cesfam.
no tiene contacto con papá; no hay parte de él.
genera inestabilidad emocional; además no paga pensión
ahora le ha gustado venir al colegio,
al anterior no
le gusta el arte

- Derivar a posible TEA
Sobrino de mamá con TEA.